（四）房颤心律变规则的原因

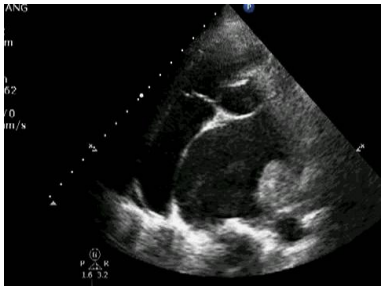
①恢复了窦性心律

②转为其它心律规则的心律失常（如固定比例的房扑、异位心动过速）

③强心苷中毒导致三度房室传导阻滞

明显抑制房室结传导

房颤患者长期使用强心苷，心律突然变规则了，心室率变得很慢，什么原因？强心苷中毒导致的三度房室传导阻滞



左心房凝血因子打转转→左心房易形成附壁血栓→左心室→体循环→脑栓塞

（五）治疗

抗凝转复控心率

1.根治：导管消融

2.长期抗凝（房颤怕栓怕快；心房失去收缩力致血流淤滞、凝血因子打转转）

（1）合并心瓣膜病（尤其中重度二尖瓣狭窄、机械瓣）→华法林抗凝，维持凝血酶原时间 INR 在 2-3（林 I23）。

华法林导致严重出血用维生素 K

作用更强

VitK的抑制剂

（2）没有合并心瓣膜病→CHA_2DS_2-VASc 评分（差多少哇上车）

男	女	
0	**1**	**不抗凝**
1	2	权衡获益与风险考虑抗凝
≥2	≥3	需抗凝

表 3-3-2　非瓣膜病性心房颤动脑卒中危险 CHA_2DS_2-VASc 评分

危险因素	CHA_2DS_2-VASc/分
心力衰竭/左心室功能障碍（C）	1
高血压（H）	1
年龄≥75 岁（A） 气我	2
糖尿病（D） 短暂性的脑缺血发作	1
脑卒中/TIA/血栓栓塞病史（S）	2
血管疾病（V）	1
年龄 65～74 岁（A）	1
性别（女性，Sc） 雌激素会加重血液凝固	1

肺栓塞抗凝：动次撒

服用雌激素或临时制动：≥3个月

注：TIA，短暂性脑缺血发作。血管疾病包括：既往心肌梗死、外周动脉疾病、主动脉斑块。

在非瓣膜性房颤抗凝时：

①首选新型口服抗凝药——达比加群、利伐沙班（班群），不需常规监测凝血指标（更安全）。若达比加群导致严重出血用依达赛珠单抗（达）

②经皮左心耳封堵术：不适合长期抗凝或即使抗凝仍发生脑卒中/栓塞、HAS-BLED≥3 分（高出血风险 blood）

最易形成附壁血栓

表 3-3-3　出血风险评估 HAS-BLED 评分

临床特点	计分/分
未控制的高血压（H）	1
肝、肾功能异常（各 1 分，A）	1 或 2
脑卒中（S）	1
出血（B）	1
INR 易波动（L）	1
老年（年龄>65 岁，E）	1
药物或嗜酒（各 1 分，D）	1 或 2
最高值	9 分

注：未控制的高血压定义为收缩压>160mmHg；肝功能异常定义为慢性肝病（如肝纤维化）或胆红素>2 倍正常值上限，丙氨酸转氨酶>3 倍正常值上限；肾功能异常定义为慢性透析或肾移植或血清肌酐≥200μmol/L；出血指既往出血史和/或出血倾向；INR 易波动指 INR 不稳定，在治疗窗内的时间<60%；药物指合并应用抗血小板药物或非甾体抗炎药。